შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო
245435514
ცნობა # 52259

დამტკიცებულია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
2008 წ. 15.10 №230/ნ ბრძანებით

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა № IV-100/ა

ცნობა
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან/და ექიმი სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა. სახელმწიფო სერთიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ წარსადგენად

3. პაციენტის სახელი და გვარი **ტატიანა ალიევა**

4. დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) **26/08/1961**

5. პირადი ნომერი **675915966**

(ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)

6. მისამართი **ბათუმი გორგილაძის 28**

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში - იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი. სადაც იგი სწავლობს)

8. თარიღები: ა) ექიმთან მიმართვის

ბ) სტაციონარში გაგზავნის

გ) სტაციონარში მოთავსების **13-09-2026 14:38**

დ) გაწერის **23-09-2026 09:00**

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

ძირითადი დიაგნოზი:
S06.6 - ტრავმული სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა
თანმხლები დიაგნოზი:
E11.5 - ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით
I69.3 - ტვინის ინფარქტის შედეგები

10. გადატანილი დაავადებები

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტი შემოსვლისას უჩივის ძლიერ თავის ტკივილს, თავბრუსხვევას, გულისრევას, ღებინებას, მეტყველების გაძნელებას. ; პაციენტი მოყვანილი არის 112 ის ბრიგადის მიერ. ანამნეზის მიხედვით

პაციენტი დაეცა ქუჩაში გადაადგილების დროს, დაარტყა თავი, დაკარგა გონება. გონზე მოსვლის შემდეგ პაციეტნი ძილიანია, საუბრობს დიზართრიულად.კლინიკაში გაუკეთდა თავის ტვინის კ.ტ.კვლევა კონტრასტით,ნეიროქირურგის კონსულტაცია და მოთავსდა ნეიროქირურგიულ გან-ში.;

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

C ჰეპატიტის განსაზღვრა იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით (სწრაფი,მარტივი) HCV(1)
გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში (GLUC)(1)
ელექტროკარდიოგრაფია 12 სტანდარტულ განხრაში (ეკგ)(1)
თავის და თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია(2)
კოაგულაციური ჰემოსტაზის გამოკვლევა (PT, APTT, INR, FIBR, TT)(1)
კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (CREA)(1)
მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა(1)
ნეიროქირურგის კონსულტაცია(1)
სისხლის საერთო ანალიზი(1)
სისხლში აირების და ელექტროლიტების განსაზღვრა(1)
ქიმიური აგენტების გამოყენება (CT კონტრასტი)(1)

ლაბორატორიული კვლევები

დასახელება	შედეგი	ნორმა
2026-09-13		
ლეიკოციტები (WBC)	9.67 10^9/L	4 - 10
ნეიტროფილი ჩხირბირთვიანი (NEU)	4.39 10^9/L	2 - 7
ლიმფოციტები (LYMPH)#	4.29 10^9/L	0.8 - 4
მონოციტები (MONO)#	0.62 10^9/L	0.12 - 1.2
ეოზინოფილები (EOS)#	0.15 10^9/L	0.02 - 0.5
ბაზოფილები (BAS)#	0.05 10^9/L	0 - 0.1
მოუმწიფებელი გრანულოციტები IMG#	0.17 10^9/L	0 - 0.04
ნეიტროფილი სეგმენტბირთვიანი (NEU)%	45.30 %	50 - 70
ლიმფოციტები (LYMPH)%	44.40 %	20 - 40
მონოციტები (MONO)%	6.40 %	3 - 12
ეოზინოფილები (EOS)%	1.60 %	0.5 - 5
ბაზოფილები (BAS)%	0.50 %	0 - 1
მოუმწიფებელი გრანულოციტები IMG%	1.80 %	0 - 100
ერითროციტები (RBC)	4.22 10^12/L	3.5 - 5.5
ჰემოგლობინი (HGB)	136 g/L	110 - 150
ჰემატოკრიტი (HCT)	40.00 %	37 - 47
ერითროციტების საშ. მოცულობა (MCV)	94.70 fl	80 - 100
ჰემოგლობინის საშ. შემცველობა (MCH)	32.20 pg	27 - 34
ჰემოგლობინის საშ. კონცენტრაცია საერთო ერითროციტულ მასაში (MCHC)	340 g/L	320 - 360
ერითროციტების გადანაწილების საზღვრები (RDW-CV)	12.30 %	11 - 16
ერითროციტების გადანაწილების ფართობი (RDW-SD)	42.00 fl	35 - 56
თრომბოციტები (PLT)	152 10^9/L	100 - 300
თრომბოციტების საშ. მოცულობა (MPV)	11.50 fl	6.5 - 12
თრომბოციტების გადანაწილების საზღვრები (PDWc)	16.90 (10GSD)	15 - 17
თრომბოკრიტი (PCT)	1.75 mL/L	1.08 - 2.82
დიდი ზომის თრომბოციტის უჯრედების რაოდენობა	54 10^9/L	30 - 90
დიდი ზომის თრომბოციტის უჯრედების თანაფარდობა	35.60 %	11 - 45
2026-09-16		
ჰეპატიტ C–ს მარკერი Anti-HCV (სწრაფი, მარტივი მეთოდით) განსაზღვრა სისხლში	უარყოფითი (-)	უარყოფითი
ტრომბოპლასტინის აქტივირებული ნაწილობრივი (პარციალური) დროის განსაზღვრა - APTT	21.53 წმ	21 - 37
პროთრომბინის დროის განსაზღვრა სისხლში (PT)	13.28 წმ	9.2 - 15
პროთრომბინის ინდექსი	99.09 %	70 - 120
INR-ის განსაზღვრა	1.10	0.8 - 1.3
ფიბრინოგენის განსაზღვრა სისხლში	459.38 mg/dl	200 - 400
თრომბინის დროის განსაზღვრა (TT)	13.91 წმ	10 - 20
კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში	69.49	46 - 92
გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში	13.82 mmol/L	3.6 - 5.8

ინსტრუმენტული კვლევები

2026-09-13
AADD1A - თავის და თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია -

ოქმის ნომერი:150-4

დასხივების საერთო დოზა-1.863 msv.

გამოყენებული აპარატურა:Aquilion Prime

ნატივ და კონტრასტულ კტ.ჭრილებზე მიღებულია თავის ტვინის სუბ-სუპრატენტორიალური სტრუქტურების გამოსახულება კორონარულ, საგიტალურ ჭრილებში და 3 D რეკონსტრუქციები.

გავლილ ტომოგრამებზე: ბაზალური ცისტერნების ,მარცხნივ სილვიის ცისტერნის, შუბლის არეში , მარჯვნივ საფეთქლის არეში წილის ერთეული სუბარაქნოიდული სივრცეები, წინა ჰემისფეროთაშორისი ნაპრალის პროექციაში ისახება მკაფიო კონტურებიანი ხაზოვანი ჰემორაგიული კომპონენტი..მარჯვნივ ბაზალური ბირთვების არეში ისახება ჰიპოდენსიური - ლიქვორის სიმკვრივესთან მიახლოვებული კერა პერიფოკალური შეშუპების გარეშე, პირობითი ზომით: 24,0 x 5,2მმ. მმ.სუბარაქნოიდული კონვექსიტალური სივრცეები მკფიოდ ისახება. ტვინის პარკუჭოვანი სისტემა დეფორმული არ არის.. გვერდითი პარკუჭები მცირედ ასიმეტრიულია.ტვინის ნივთიერების სიმკვრივე პერივენტრიკულურ ზონაში დაქვეითებულია.. თურქული კეხი სწორი მკაფიო კონტურებით..სელარული, ხიაზმალური მიდამო პათოლოგიის გარეშეა. შუამდებარე სტრუქტურები ცდომილი და დეფორმული არ არის.უკანა ფოსოს სტრუქტურები მკაფიოდ დიფერენცირდება...ნათხემის ჰემისფეროები სიმეტრიულია.ნათხემ-ხიდის კუთხე თავისუფალია. მეოთხე პარკუჭი შუა ხაზზეა, გამტარია. მეოთხე პარკუჭზე და ღეროს სტრუქტურებზე ზეწოლა არ არის.. კრანიო–ვერტებრული გადასასვლელი დეფორმული არ არის ნათხემის ნუშურები ისახება კეფის დიდი ხვრელის ზემოთ. ორბიტები სიმეტრიული, თვალის კაკალი , თვალის მამოძრავებელი კუნთები ,ქალა-სარქვლის, ქალა-ფუძის ძვლები ხილული პათოლოგიის გარეშეა.პარანაზალური წიაღები, დაფის ღრუ პნევმატიზებულია.მარცხნივ კეფის მიდამოში ისახება კანქვეშა ჰემატომა.

დასკვნა:ჩატარებული კტ. კვლევით ვლინდება წინა ცირკულაციის მწვავე სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცება . ქრ. ინფარქტი მარჯვნივ ბაზალური ბირთვების არეში. კეფის მიდამოს კეფალოჰემატომა მარცხნივ.

2026-09-16
JXDE3A - მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა -

ღვიძლის მარჯვენა წილის ირიბი-ვერტიკალური ზომა 154მმ, მარცხენა წილის სისქე 65მმ, კიდეები მომრგვალებული. პარენქიმის ექოსტრუქტურა ერთგვაროვანი. ექოგენობა მომატებული. ბგერითი გამტარებლობა დაქვეითებული. ღვიძლის სისხლძარღვოვანი სურათი - მწირი კარის ვენის დიამეტრი 12 მმ (ნორმა <13 მმ). ღვიძლშიდა და ღვიძლგარე სანაღვლე გზები არ არის დილატირებული. ნაღვლის საერთო სადინარი დიამეტრი 2 მმ.

ნაღვლის ბუშტი ზომით: 54 X 22მმ. კედლის სისქე 2მმ. მომატებული ექოგენობის, არაჰომოგენური შიგთავსით.

კუჭუკანა ჯირკვალი ნორმალური ზომებით, კონტურები მკვეთრი, ტალღოვანი, ექოსტრუქტურა ერთგვაროვანი, მომატებული ექოგენობის, პანკრეასის მთავარი სადინარი არ არის გაგანიერებული.

ელენთა ნორმალური ზომით და ექოსტრუქტურით. ელენთის ვენის დიამეტრი კართან 6მმ.

თირკმელები ნორმალური ფორმის, ზომის, კონტური სწორი.პარენქიმის სისქე - 15-14მმ. პარენქიმის ექოგენობა -საშუალო . კორტიკო - მედულური დიფერენცირება -სუსტად გამოხატული. მენჯ-ფიალოვანი სისტემა არ არის დილატირებული.

შარდის ბუშტი მცირე შევსებით,

მუცლის ღრუში თავისუფალი სითხე არ ისახება. გამოხატულია მეტეორიზმი.

2026-09-21
AADD1A - თავის და თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფია -

ოქმის ნომერი:52-4

დასხივების საერთო დოზა-1.863 msv.

გამოყენებული აპარატურა:Aquilion Prime

ნატივ და კონტრასტულ კტ.ჭრილებზე მიღებულია თავის ტვინის სუბ-სუპრატენტორიალური სტრუქტურების გამოსახულება კორონარულ, საგიტალურ ჭრილებში და 3 D რეკონსტრუქციები.

წინა კვლევასთან შედარებით ბაზალური ცისტერნების ,მარცხნივ სილვიის ცისტერნის, შუბლის არეში , მარჯვნივ საფეთქლის არეში წილის სუბარაქნოიდული სივრცეების, წინა ჰემისფეროთაშორისი ნაპრალის პროექციაში არსებული სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა სრულად ალაგებულია. მარჯვნივ ბაზალური ბირთვების არეში ისახება ჰიპოდენსიური - ლიქვორის სიმკვრივესთან მიახლოვებული კერა პერიფოკალური შეშუპების გარეშე, პირობითი ზომით: 24,0 x 5,2მმ. მმ.სუბარაქნოიდული კონვექსიტალური სივრცეები მკფიოდ ისახება. ტვინის პარკუჭოვანი სისტემა დეფორმული არ არის.. გვერდითი პარკუჭები მცირედ ასიმეტრიულია.ტვინის ნივთიერების სიმკვრივე პერივენტრიკულურ ზონაში დაქვეითებულია.. თურქული კეხი სწორი მკაფიო კონტურებით..სელარული, ხიაზმალური მიდამო პათოლოგიის გარეშეა. შუამდებარე სტრუქტურები ცდომილი და დეფორმული არ არის.უკანა ფოსოს სტრუქტურები მკაფიოდ დიფერენცირდება...ნათხემის ჰემისფეროები სიმეტრიულია.ნათხემ-ხიდის კუთხე თავისუფალია. მეოთხე პარკუჭი შუა ხაზზეა, გამტარია. მეოთხე პარკუჭზე და ღეროს სტრუქტურებზე ზეწოლა არ არის.. კრანიო–ვერტებრული გადასასვლელი დეფორმული არ არის ნათხემის ნუშურები ისახება კეფის დიდი ხვრელის ზემოთ. ორბიტები სიმეტრიული, თვალის კაკალი , თვალის მამოძრავებელი კუნთები ,ქალა-სარქვლის, ქალა-ფუძის ძვლები ხილული პათოლოგიის გარეშეა.პარანაზალური წიაღები, დაფის ღრუ პნევმატიზებულია.

დასკვნა: წინა კვლევასთან (13.09.2026.) შედარებით დინამიკა პოზიტიურია.

კონსულტაციები

2026-09-13
- ნეიროქირურგის კონსულტაცია -

პაციენტი მოყვანილი არის 112 ის ბრიგადის მიერ. ანამნეზის მიხედვით პაციენტი დაეცა ქუჩაში გადაადგილების დროს, დაარტყა თავი, დაკარგა გონება. გონზე მოსვლის შემდეგ პაციეტნი ძილიანია, საუბრობს დიზართრიულად. ვიტალური პარამეტრები Ta120/70mm.hg Ps75' Rr15' SpO2-99% T36.6oC. უჩივის თავის ტკივილს, თავბრუსხვევას, გულისრევას, ღებინებას, მეტყველების გაძნელებას. მენინგეალური ნიშნები არ ვლინდება. გუგები თანაბარი. ცნობიერება 14 ქულა, თვალის გახელა 4 ქულა, ვერბალური პასუხი 4 ქულა, მოტორული რეაქცია 6 ქულა. მენინგეალური ნიშნები არ ვლინდება. კოორდინაციულ ცდებს ასრულებს აცდენით ორმხრივად.

წინასწარი დიაგნოზი ტრავმული სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა S06.6

დასკვნა:ჩატარებული კტ. კვლევით ვლინდება წინა ცირკულაციის მწვავე სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცება . ქრ. ინფარქტი მარჯვნივ ბაზალური ბირთვების არეში. კეფის მიდამოს კეფალოჰემატომა მარცხნივ.

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

მედიკამენტური მკურნალობა

მეტოკლოპრამიდ-დარნ5მგ/მლ2მლ#10 - i.v., ნატრიუმის ქლორიდი 0.9% 500მლ - i.v., ცეფტა(ცეფტრიაქს) 1გ N1 ფლ. - i.v., ნეიროლეფსინი ტაბ.400მგ N50 GMP - p.o., ფუროსემიდი 1%/2მლ#5ა(თურქ) - i.v., ტრანექსამის მჟავა 500მგ/5მლ#5ა - i.v., კეტამო 30მგ/1მლ#10ი.ვ/მ - i.v.,

15. მდგომარეობა სტაციონარში მოთავსებისას

არასტაბილური

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

სტაბილური

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

რეჟიმი

წოლითი

რეკომენდაცია

ვინაიდან პაციენტს 1 წლის წინ ჰქონდა იშემიური ინსულტი და ამჟამად აქვს ტრავმული სუბარაქნოიდალური სისხლჩაქცევა,პაციენტის ტრანსპორტირება ქალაქ მოსკოვში უნდა განხორციელდეს ბიზნეს კლასით ნახევრად მწოლიარე მდგომარეობაში.საჭიროებს წნევისა და გლუკოზის კონტროლს.ჩასვლისთანავე ნევროლოგის მეთვალყურეობას.

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი სპეციალისტი) **გიორგი კიკაბიძე**

19. დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის/მკურნალი ექიმის (ექიმი-სპეციალისტის) ხელმოწერა: ლევან ბეჟანიძე



20. ცნობის გაცემის თარიღი **23.09.2026**

ბეჭდის ადგილი

